2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

POLIFARMÁCIA E PREVENÇÃO QUATERNÁRIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE RACIONALIZAÇÃO TERAPÊUTICA EM UMA UBS

Michel Emerson dos Santos[1], Lyzandra Holanda Lopes Beserra [1], David Lisboa Silva[1], Antonio Bernardo Nascimento Vieira[1], Igor Duarte de Oliveira[1]
[1] Universidade Federal de Alagoas

ANTES	DEPOIS
Muitas prescrições	Revisão terapêutica
Confusão de horários	Organização com pictogramas
Risco de interações	Uso racional
Baixa autonomia	Segurança do paciente

- **Maior compreensão dos regimes terapêuticos pelos usuários**
- **Identificação de prescrições potencialmente inadequadas**
- **Fortalecimento da corresponsabilização no cuidado**
- **Melhora na segurança do paciente**
- **Integração ensino-serviço na qualificação do cuidado**

Introdução

A polifarmácia é comum na Atenção Primária à Saúde (APS), especialmente em idosos e pessoas com multimorbidades, estando associada a eventos adversos, interações medicamentosas e fragmentação do cuidado.

Nesse cenário, a prevenção quaternária surge como estratégia para evitar intervenções desnecessárias e promover o uso racional de medicamentos.

Objetivos

- Promover organização do uso medicamentoso
- Estimular revisão crítica das prescrições
- Aplicar princípios da prevenção quaternária na APS
- Fortalecer segurança e autonomia dos pacientes

Métodos

- Tipo de estudo: Relato de experiência extensionista
- Local: UBS urbana com abrangência rural – Arapiraca/AL
- Público-alvo: Usuários em polifarmácia (uso contínuo de múltiplos fármacos)
  - Etapas da intervenção:
    - Sensibilização da equipe multiprofissional
    - Identificação ativa de pacientes em polifarmácia
    - Educação em saúde (reuniões + sala de espera)
    - Elaboração de esquemas terapêuticos individualizados
    - Uso de pictogramas para horários e doses
    - Estímulo à revisão de medicamentos sem indicação atual

Resultados

- Melhor entendimento dos esquemas terapêuticos
- Redução de confusões relacionadas a horários e doses
- Identificação de uso potencialmente inadequado de medicamentos
- Maior diálogo entre equipe e pacientes
- Aumento da segurança e adesão terapêutica

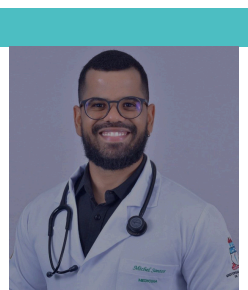
Conclusão/Considerações finais

A experiência reforça o papel da APS na coordenação do cuidado terapêutico, destacando a prevenção quaternária como ferramenta essencial para redução de intervenções desnecessárias. Contribui para um cuidado mais seguro, integral e centrado no paciente.

MAIS MEDICAMENTOS ≠ MELHOR CUIDADO
CUIDADO ADEQUADO = INDICAÇÃO + BENEFÍCIO + SEGURANÇA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
MICHEL EMERSON DOS SANTOS
ACADÊMICO DE MEDICINA

E-mail: michel.santos@arapiraca.ufal.br
Contatos: (79) 99691-3773
Website:



UFAL
SELO ODS EDUCAÇÃO 2025